

Como se usa el portal

Manual para el kinesiólogo. No hace falta leerlo entero: cada seccion es una tarea suelta. Buscá la que necesites.

Adentro del portal hay ayuda en cada pantalla.

Arriba a la derecha de todas las pantallas hay un boton redondo con un signo de pregunta. Tocalo y te explica esa pantalla: para que sirve, como se usa paso a paso, y donde suele estar la trampa.

Este manual es lo mismo, pero en papel y todo junto.

Que hay en el menu

Seccion	Para que sirve
Panel	La pantalla de arranque. Los turnos de hoy, la plata del mes y como esta el plantel.
Agenda	Los turnos. Dar, cambiar, marcar quien vino.
Lesiones	Las fichas de los que estan en tratamiento.
Pacientes	El padron: todos los que pasaron por el estudio.
Historias	La historia clinica completa de cada uno. Documento legal.
Programas	Cargar los ejercicios que hace en casa.
Caja	Ingresos, egresos, planes y sesiones que le quedan a cada uno.
Mi perfil	Tu foto, tu logo, tu matricula. Y el boton de vaciar.
Cartel	El cartel con el codigo QR para pegar en la recepcion.
Pizarron	Dibujar circuitos en la cancha.
Ejercicios	La biblioteca de ejercicios con video.

El primer día

Tres cosas, una sola vez. Despues no se vuelven a hacer.

1

Vaciar los pacientes de prueba

El portal viene con pacientes inventados para que se vea funcionando. Marcela Rios y Diego Sosa no existen.

Anda a **Mi perfil**, baja hasta abajo de todo, y usa el boton para vaciar. Te va a pedir escribir la palabra VACIAR.

Se borran los pacientes inventados. **No** se borran las plantillas de lesion ni la biblioteca de ejercicios: eso es la herramienta.

Hacelo antes de cargar tu primer paciente de verdad. Si no, dentro de un mes no vas a saber cual es real y cual inventado. En una historia clinica eso no se puede permitir.

2

Cargar tus datos

En la misma pantalla de **Mi perfil**: tu foto, el logo del estudio, tu nombre, tu matricula y tu telefono.

La matricula sale impresa en la historia clinica, que es un documento profesional. Y el telefono es al que te llegan los avisos cuando alguien reserva un turno.

3

Imprimir el cartel

Anda a **Cartel** y toca **Imprimir el cartel**. Sale en una hoja, en blanco y negro.

Pegalo donde entra la gente. Ese codigo QR es lo que hace que no tengas que cargar datos de pacientes nunca mas.

El horario del estudio

En **Agenda**, abajo, esta el horario: a que hora abris, a que hora cerras, y cuantos minutos dura cada turno. Con eso se arma la grilla de toda la semana.

Sumar un paciente

La idea de fondo: vos no cargas datos. Los carga el paciente.

Dos formas de cargarlo

En **Pacientes**, arriba, tenes un boton **Nuevo paciente**: abre la ficha para que la cargues vos, con la persona adelante.

Pero si podes, dejá que la cargue el: es mas rapido y no hay errores de dictado. Para eso esta el codigo QR.

Con el codigo QR

1

El paciente escanea el codigo

Apunta la camara del celular al QR del cartel. Se le abre un formulario.

2

Completa sus datos en dos minutos

Nombre, documento, telefono, por que viene, de que trabaja, que deporte hace, cirugias anteriores y que quiere volver a poder hacer. Y autoriza que guardes sus datos, que por ley es obligatorio.

3

Aparece solo en tu padron

Entra a **Pacientes** y ahi esta, marcado como **sin atender**. Ese cartelito se le va cuando le cargues la primera sesion.

Si no tenes el cartel a mano, en **Pacientes** hay botones para mandarle el enlace por WhatsApp o para compartirlo. Es lo mismo.

Que le vas a preguntar el primer dia

Casi nada, porque ya esta todo cargado. Lo que si conviene mirar antes de que entre: el **motivo de consulta** escrito con sus palabras, los **antecedentes** (puede haber una cirugia que contraindique ejercicios enteros) y sobre todo el **objetivo**.

El objetivo es el campo mas importante de todos: es contra lo que se va a medir si el tratamiento sirvio. "Volver a nadar 2000 metros sin dolor" es un objetivo. "Estar mejor" no lo es.

Un día de trabajo

Esto es lo que vas a hacer quince veces por día. Es un solo botón.

Atender a alguien que llega

1

Entra al Panel

Ves los turnos del día en orden. El que está por venir dice **atender**.

2

Toca el turno de esa persona

Se abre una sola pantalla con todo lo de esa sesión. No hay que ir a ningún otro lado.

3

Completa mientras atiendes

Si vino o faltó. Que tipo de sesión fue. Cuanto le dolía al llegar y cuanto al terminar. Que se hizo, si quieres anotarlo. Y de una vez, el próximo turno.

4

Toca confirmar

El botón te dice cuantas cosas va a hacer. En un solo toque: queda marcado que vino, se le descuenta la sesión del plan, se cobra si paga por sesión, se guarda en su ficha, se asienta en la historia clínica, y le queda el próximo turno reservado.

Los dos valores de dolor son obligatorios; la nota no.

La diferencia entre el dolor al llegar y al terminar es el dato que muestra si la sesión sirvió. Sin esos dos números el resto no dice nada.

Si el paciente falta

Marca **Falto**. No se le descuenta la sesión ni se cobra, pero queda contado en el porcentaje de ausencias del mes.

Ese porcentaje es el número que más plata mueve en un estudio: cada hueco es una hora que no se recupera. Lo ves en el Panel y en Caja.

Abrir una lesion

Es lo que convierte a alguien del padron en alguien en tratamiento.

1

Entra al paciente

Desde **Pacientes**, tocalo y despues **Abrir una lesion**.

2

Elegi zona, lado y gravedad

Tobillo, rodilla, hombro, muslo, lumbar u otra. Y que tan grave es, de leve a grave.

3

Lo demas se completa solo

Los criterios de cada fase salen de la zona que elegiste. La fecha estimada de alta se calcula con la zona y la gravedad. Y el parte medico lo marca como de baja.

Todo eso lo podes corregir despues desde la ficha.

Los dos relojes

Arriba de cada ficha hay dos numeros distintos: los **dias desde la lesion o la cirugia**, y los **dias que lleva tratandose**.

No son lo mismo, y confundirlos hace daño. Alguien que se opero hace 90 dias pero empezo la rehabilitacion hace 10 no esta atrasado: recien empieza. Con un solo numero eso no se ve, y es la diferencia entre apurar a un paciente o entenderlo.

Si la espera entre la lesion y la primera sesion fue de mas de una semana, el portal te lo avisa en la ficha.

Cuando abris una lesion te pregunta si hubo cirugia. Si la hubo, el reloj cuenta desde ahi: es la fecha que usa toda la literatura de retorno al juego.

Las cinco fases

Fase	Que se busca	Cancha
1 Proteccion	Bajar el dolor y proteger la zona	No
2 Rango	Recuperar movilidad y fuerza	No
3 Readaptacion	Fuerza especifica y aterrizajes	Gimnasio
4 Reintegro	Volumen parcial, gesto tecnico	Parcial
5 Alta	Competir sin restricciones	Si

Por que el boton de avanzar esta apagado

Porque faltan criterios por cumplir. El boton se enciende solo cuando estan todos tildados.

No es un capricho del programa. La evidencia sobre retorno al juego muestra que volver antes de tiempo aumenta mucho el riesgo de recaida, y que el alta tiene que darse por criterios cumplidos y no por dias transcurridos. La fecha estimada sirve para avisarle al entrenador, no para decidir.

Al pasar de fase, los criterios se vacian y aparecen los de la fase nueva. Cada fase se gana de nuevo.

Al llegar a la fase 5 la lesion se cierra sola. El paciente pasa a figurar disponible en el parte medico, y la ficha queda guardada en su historial.

Cargar los ejercicios

Lo que el paciente hace en casa, con el video al lado.

1

Anda a Programas

Elegi al paciente. Los que no tienen lesion abierta aparecen apagados: primero hay que abrirles una.

2

Elegi la fase

Cada fase tiene su programa. Podes dejar armada la proxima antes de que el paciente llegue a ella.

3

Suma de la biblioteca

Toca **Sumar de la biblioteca**. Los de la zona lesionada aparecen primero. Vienen con la dosis sugerida ya puesta.

4

Ajusta la dosis

Series, repeticiones y carga. Las repeticiones son texto libre a proposito: sirve tanto "12" como "30 seg" o "10 por lado".

5

Pega el enlace del video

Si tenes el ejercicio filmado. Funciona con YouTube, Vimeo o un archivo de video.

6

Guarda

En ese momento el paciente lo ve en su celular. No hay que avisarle nada.

Los videos no se guardan adentro del portal, porque pesan demasiado. Se suben a YouTube o Vimeo y aca se pega el enlace.

Si vas a filmar tus propios ejercicios, en YouTube subilos como **ocultos**: no aparecen en las busquedas, pero funcionan con el enlace.

La historia clinica

Se escribe sola mientras trabajas. Es un documento legal.

Que se asienta solo

Cada cosa que haces genera un asiento numerado, con fecha, hora y tu nombre: el alta del paciente, el consentimiento, la apertura de la lesion, cada sesion, cada criterio que tildas, cada cambio de fase y el alta final.

Vos no haces nada distinto. Se escribe mientras atendes.

No se puede editar el pasado

Corregir algo no borra lo anterior: agrega una rectificacion que apunta al asiento equivocado. Es como en papel, donde uno tacha y firma al lado en vez de arrancar la hoja.

Arriba de la historia hay un cartel que dice si esta integra. Si alguien modificara un asiento viejo, el sistema lo detecta y lo avisa.

Los estudios complementarios

Ecografias, resonancias, radiografias, informes. Van pegados a la historia clinica, que es donde corresponde.

Lo mejor es una foto del estudio o un recorte de la imagen que importa: se achica sola, pesa poco y se ve al instante. Un PDF sirve si es un informe de texto.

Un PDF de resonancia pesa entre 5 y 60 megas. Guardarlos adentro haria el portal lento y caro, asi que si el archivo es grande el portal te avisa y te ofrece pegar un enlace: el archivo queda donde ya esta y el portal guarda la direccion.

De todas formas, una foto de la imagen concreta suele ser mas util que las trescientas imagenes del estudio completo.

El paciente puede pedirte una copia

Por ley el paciente es el titular de su historia clinica y podes tener que darsela dentro de las 48 horas. En el portal es un boton: **Descargar en PDF**. El paciente tambien la ve entera desde su celular, en **Mi historia**.

Quien vio que

Abajo de cada historia queda la lista de accesos: quien la abrio y cuando. El paciente no ve esa lista.

El cuerpo tecnico nunca ve el diagnostico.

Si el paciente es del plantel, el entrenador ve solamente si esta disponible, limitado o de baja, y para cuando vuelve. Nada mas. El diagnostico es un dato de salud y no lo necesita para armar el equipo.

La plata

Planes, sesiones que quedan, lo que entra y lo que sale.

Los planes

Plan	Como funciona
Plantel del club	Lo cubre el club. No se factura por sesion.
Sesion a sesion	Paga cada vez que viene. Se cobra al marcar que vino.
Plan de 10	Diez sesiones. Se descuenta una por cada sesion atendida.
Mensual libre	Todas las sesiones del mes, sin descontar.
Asesoría online	Rutinas y seguimiento por la app, sin sesiones presenciales.
Premium	App, sesiones libres y atencion personalizada.

La sesion se descuenta cuando marcas que vino, no cuando reserva.

Si se descontara al reservar, una cancelacion a tiempo le comería una sesion al paciente y terminarias discutiendo por WhatsApp.

Que se anota solo y que cargas vos

Se anotan solos: los planes que vendes y las sesiones sueltas que atendes.

Los cargas vos: los gastos. Alquiler, luz, insumos, equipamiento. Es un concepto y un monto, en la pantalla de **Caja**.

Quien se esta quedando sin sesiones

En Caja, en la lista de planes, los que tienen dos sesiones o menos aparecen marcados en ambar, y los que no tienen ninguna en rojo. Conviene avisarles antes de que lleguen a cero.

Lo que ve el paciente

Conviene que lo sepas, porque te lo va a preguntar.

El ve solo lo suyo. Nunca ve otros pacientes, ni la agenda completa, ni la caja. En los turnos de otros ve la palabra "ocupado", nunca de quien son.

Pantalla	Que hace ahi
Mi recuperacion	En que fase esta, que le falta para la siguiente, cuando es su turno, y sus ejercicios de hoy con video.
Mis turnos	Reservar un horario libre. Te llega el aviso.
Como estoy	Cinco preguntas diarias: sueño, cansancio, dolor muscular, animo y estres. Medio minuto.
Mi historia	Su historia clinica completa. La puede descargar.

Los ejercicios y el registro

Cada ejercicio se abre entero: el **video arriba** con su nombre, y debajo **una fila por serie** donde el paciente anota el peso que uso de verdad y las repeticiones que le salieron. Entre serie y serie hay un boton de descanso que cuenta 60 segundos.

Por que el peso se anota por serie y no una sola vez.

Tres series de 12 con 8 kilos no es lo mismo que 12 con 10, 12 con 8 y 8 con 6. La segunda te dice que se quedo sin fuerza en la ultima, y que la carga esta al limite. Con un solo numero esa informacion se pierde.

Ademas le mostramos que uso la vez anterior, asi no tiene que acordarse.

El paciente tilda cada ejercicio a medida que lo hace, y al final marca cuanto le dolio y que tan exigente le resulto. Eso te llega a vos.

Es el dato que te dice si el estancamiento es del tratamiento o de que no lo esta haciendo. Sin eso estas adivinando.

Las cinco preguntas diarias

Se completan **despues** de entrenar, no antes. Si se cargan antes, estan midiendo como amanecio, no como lo dejo el entrenamiento.

Los mensajes y los avisos

Lo que se agrego al final, y es lo que mas cambia el dia a dia.

El paciente ahora te puede escribir

Al lado de cada ejercicio tiene un boton de consultar. Lo que escribe queda pegado a ESE ejercicio, asi sabes exactamente de cual habla. No es un chat suelto.

Lo ves en tres lugares: en el aviso del panel, en el padron con un cartelito rojo, y desde la ficha de la lesion.

El portal le dice al paciente que respondes antes de su proximo turno, y que esto NO es una guardia. Sin eso, un chat es una trampa: el paciente escribe a las tres de la mañana creyendo que alguien lo lee.

Los avisos del panel

Arriba de todo, antes que los turnos. Cruzan solos tres cosas que ya se cargan todos los dias: el dolor de cada sesion, si hizo o no sus ejercicios, y los mensajes sin responder.

Cuando salta	Que te dice que hagas
El dolor le sube tres sesiones seguidas	Bajarle la carga antes de seguir.
Termina peor de como llega, dos veces	Revisar que se hace en sesion.
Hizo menos de la mitad de sus ejercicios	Preguntarle por que.
Hace cinco dias que no registra nada	Escribirle antes de que abandone.
Cumplio todos los criterios de la fase	Pasarlo a la siguiente.
Se paso de la fecha estimada de alta	Reestimarla y avisarle al entrenador.
Te escribio y no le respondiste	Responderle.

Ninguna alerta dice solamente que algo anda mal: todas dicen que hacer. Un aviso sin accion es ruido.

La agenda

Arriba hay un calendario del mes. Con las flechas cambias de mes y podes ir todo lo lejos que quieras: los turnos existen para cualquier fecha, sin limite. No hay que "crear" el mes que viene.

Cada dia muestra puntitos: uno por cada turno tomado. Sirve para ver como viene la semana de un vistazo, sin entrar dia por dia.

Abajo del calendario esta el horario del estudio: a que hora abris, a que hora cerras, cuantos minutos dura cada turno y que dias atendes. De ahi salen todos los turnos. Si lo cambias, se

recalcula todo.

Reservar varias sesiones de una.

Quien compra un plan de diez no quiere pedir turno diez veces. Con el boton "Reservar una serie" elegis el paciente, los dias de la semana y la hora, y se reservan todas juntas. Si alguna fecha esta ocupada, la saltea y te avisa cuantas pudo poner.

El turno

El paciente ahora puede confirmar con "Ahi voy" o avisar que no puede. En tu agenda los confirmados salen marcados.

Y tenes un boton de **Recordar** que arma el mensaje y lo manda por WhatsApp de un toque. Solo aparece en los que todavia no confirmaron.

El pizarron de circuitos

Para los trabajos de campo, en la cancha.

Elegi la cancha (entera, media, espacio reducido o gimnasio), toca un elemento de la izquierda y despues toca la cancha para colocarlo. Con **Mover** arrastras lo que ya esta puesto.

Los recorridos se dibujan arrastrando de un punto a otro: **Correr** es flecha derecha, **Conducir** es ondulada (con pelota) y **Pase** es punteada.

Despues numeras las postas y escribis que se hace en cada una. Se guarda en la biblioteca y se puede sumar al programa de cualquier paciente.

Anda mejor en la computadora que en el celular: dibujar un circuito con el dedo es incomodo. En el celular sirve para consultarlo.

Para tener a mano

Las respuestas a lo que mas se pregunta.

Quiero...	Anda a...
Atender a alguien que llevo	Panel, toca su turno. Se hace todo ahi.
Sumar un paciente nuevo	No lo cargues. Que escanee el QR del Cartel.
Darle turno a alguien	Agenda, toca un horario libre.
Cambiarle los ejercicios	Programas, elegilo, cambia y guarda.
Ver como viene alguien	Lesiones, abri su ficha.
Darle el alta	Lesiones, tilda los criterios de la fase 5.
Venderle un plan	Caja, boton Cambiar plan.
Anotar un gasto	Caja, columna de la derecha.
Darle su historia clinica	Historias, elegilo, Descargar en PDF.
Saber cuanto gane este mes	Panel, arriba de todo.
Entender una pantalla	El boton con el signo de pregunta, arriba.

Las tres cosas que no hay que olvidarse

Uno. Vaciar los pacientes de prueba antes de cargar el primero de verdad. Mi perfil, abajo de todo.

Dos. Los dos valores de dolor en cada sesion. La diferencia entre ellos es el dato que sirve.

Tres. El objetivo del paciente, escrito con sus palabras. Es contra lo que se mide si el tratamiento funciona.

Si algo no se entiende o falta algo, anotalo y decilo. El portal se sigue armando: lo que no sirve se cambia.